LUIGI D'ALONZO

Disabilità e potenziale educativo

EDITRICE LA SCUOLA

ni ha avuto l'opportunità di vivere con più dignità la propria esistenza: i disabili. In Italia sono attualmente circa 3.000.000, di cui 1.100.000 con difficoltà motorie, 350.000 non vedenti, 800.000 non udenti e circa 750.000 con disagio mentale.

Queste persone, che fino a trent'anni fa erano costrette a trascorrere un'esistenza nascosta e ai margini della società, possono oggi vivere con e tra gli altri, integrandosi e vedendo soddisfatti i loro bisogni grazie ai servizi sempre più efficaci presenti sul territorio. Ciò è stato possibile grazie all'evoluzione ininterrotta del concetto di persona con deficit mentale, fisico o sensoriale. Questa persona è da sempre denominata anche con il termine «handicappato», anzi si può sostenere che è questa l'espressione più utilizzata negli ultimi decenni.

È giunto però il momento di togliere tale vocabolo dal nostro linguaggio quotidiano. Riuscire ad eliminare la parola «handicap» è indispensabile per poter camminare più speditamente verso una completa e matura consapevolezza dei bisogni di queste persone e per giungere ad offrire, anche a chi ha meno potenzialità, le giuste opportunità per vivere la propria umanità in armonia con gli altri.

Giustamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità, con la pubblicazione della nuova versione della *Classificazione Internazionale* (ICIDH-2) del 2001, invita tutti a non usare più tale espressione, suggerendo di adottare «disabilità» come termine ombrello per riferirsi alle menomazioni, alle limitazioni nelle attività, ai differenti gradi di partecipazione sociale.

Nella precedente classificazione del 1980, l'*International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps*, si dichiarava: «Nell'ambito delle evenienze inerenti alla salute l'handicap è la condizione di svantaggio conseguente ad una menomazione o a una disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, sesso e fattori socio-culturali».

Tale definizione è stata completamente travisata. L'accento posto sulla sfera sociale, sul fatto che è l'ambiente sociale e culturale che limita la persona disabile nell'adempimento di un proprio ruolo nel proprio contesto di vita, non è stato capito. Il termine handicap è diventato nell'accezione comune sinonimo di persona con deficit: tu sei un handicappato perché sei paraplegico, perché sei cieco, perché sei un miodistrofico. Non si è capito che un cittadino, se trova le opportunità, se il suo contesto di vita scolastico, lavorativo, ricreativo glielo permette e lo aiuta, può superare lo *svantaggio che ne limita o impedisce l'adempimento di un ruolo normale*. Si è travisato il concetto, non si è compreso che tutti possono incorrere in situazioni di vita dove si è limitati o impediti. Basta molto poco: se ci rompiamo una gamba e dobbiamo andare al quarto piano di un edificio privo di ascensore, possiamo toccare con mano il nostro bisogno di superare l'handicap creato da un ambiente che non ha eliminato le barriere architettoniche.

L'OMS nella nuova versione (*International Classification of Functioning, Disability and Health*) parla di funzioni, di disabilità, di fattori contestuali ambientali, di partecipazione sociale, come possiamo immediatamente notare dallo schema riportato a pagina seguente.

Scompare il termine «handicap» perché non esiste l'handicap, né l'handicappato, ma esistono persone – uomini, donne, giovani, bambini – che hanno dei problemi a livello del funzionamento mentale, fisico, sensoriale, le quali hanno bisogno di essere tutelate dalla nostra società, con urgenza, per esprimere al massimo le proprie potenzialità.

L'OMS vuole passare da un modello medico ad un modello sociale. Il modello medico vede la disabilità come un problema della persona direttamente causato dalla malattia, dal trauma sofferto, dalla sindrome posseduta e prevede di intervenire professionalmente sul «paziente» per cercare di alleviare le sue sofferenze o le sue difficoltà. Nel modello sociale, invece, si valuta la disabilità come un problema di carattere eminentemente relazionale e culturale, in cui la disabilità non è considerata un attributo della persona ma piuttosto una condizione che può essere provocata dall'ambiente sociale. Gestire e risolvere il problema in questo modello significa solo in parte intervenire personalmente, in quanto si sostiene, giustamente, che la responsabilità della piena partecipazione della persona

An overview of ICIDH-2				
	Part 1: Functioning and Disability		*Part 2: Contextual Factors*	
	Body Functions & Structures	*Activities & Participation*	*Environmental Factors*	*Personal Factors*
Domains	1. Body functions 2. Body parts	Life areas (task , actions)	External influences on functioning	Internal influences on functioning
Constructs	Change in Body function (physiological) Change in Body structure (anatomical)	*Capacity* Executing tasks in a standard environment *Performance* Executing tasks in the current environment	Facilitating or hindering impact of features of the physical, social, and attitudinal world	The impact of attributes of the person
Positive aspect	Functional and structural integrity	Activity Participation	Facilitators	Not applicable
Negative aspect	Impairment	Activity limitation Participation restriction	Barriers / hindrances	Not applicable

in tutte le aree della vita civile è della collettività. Rientra nei diritti dell'individuo, nei diritti umani, avere le opportunità e trovare le occasioni per vivere questo processo di partecipazione sociale, culturale e lavorativo in un quadro di integrazione.

Lo schema a pagina 12 evidenzia molto bene come le informazioni fornite vengano suddivise dall'OMS in due parti:

1. le funzioni e le disabilità;
2. i fattori contestuali.

Questa distinzione è indicativa dell'idea che sottostà a tutto l'impianto concettuale: la persona è tale anche se affetta da una determinata sindrome, anche se è colpita da un deficit irreversibile. L'evento traumatico, la menomazione sofferta, non devono inficiare la consapevolezza che è e rimane persona. Ogni uomo, infatti, può avere nell'arco della propria esperienza di vita dei mutamenti a livello fisiologico e a livello psicologico; ogni uomo ha dei limiti, ma soprattutto, tutti hanno delle risorse da attivare, sia a livello di capacità sia a livello di performance.

Le attività e la partecipazione del disabile sono certamente condizionate dal deficit, ma anche dai fattori contestuali, ambientali e socio-personali. Se questi sono rispettosi e positivamente portati a favorire l'integrazione, il grado di benessere e la qualità della vita del soggetto disabile possono essere anche molto elevati. Come si potrà notare, questo discorso coinvolge tutti, a prescindere dalla consapevolezza che ciascuno può essere soggetto ad eventi capaci di cambiare l'esistenza: un incidente stradale, un virus particolarmente aggressivo, un attacco cardiaco improvviso... Coinvolge tutti perché il livello e le modalità di partecipazione ai contesti ambientali, scolastici e di lavoro non rimangono ai massimi livelli per sempre, ma mutano decisamente nel corso degli anni. È molto importante, perciò, abbandonare i termini «handicap», «handicappato», «portatore d'handicap» perché inadeguati e fuorvianti.

D'altronde, se guardiamo al passato, notiamo come si siano utilizzate molte parole per indicare soggetti certamente diversi per gli aspetti fisici, mentali o sensoriali.

Queste persone, a mano a mano che la società evolveva e progrediva, sono state stigmatizzate con molti appellativi: anormali, idioti, cretini, storpi, frenastenici, handicappati, menomati, portatori d'handicap, disabili, differenti abili. Ognuna di queste parole riflette, nel contesto sociale e culturale di un'epoca, una concezione precisa della persona con deficit.

È opportuno perciò dare uno sguardo a quello che ci sta alle spalle.

1. Un cammino iniziale di rifiuto

Per comprendere appieno il presente dobbiamo volgerci al passato con metodo attento e critico. La storia può darci una chiave di lettura significativa degli avvenimenti che hanno portato l'uomo a compiere determinate scelte.

Per quanti si occupano o lavorano con le persone disabili è necessario comprendere che cosa ha portato all'attuale situazione, quali idee, quali motivi hanno condizionato l'atteggiamento nei confronti di queste persone nel nostro contesto socio-culturale.

Oggigiorno siamo arrivati ad un punto tale nella riflessione pedagogica che non è più possibile tergiversare in analisi pseudoteoriche sulla questione: i soggetti disabili hanno bisogno di risposte concrete e valide fondate sul piano scientifico e che sappiano rispondere appieno alle necessità di sviluppo reale di tutte le loro potenzialità residue.

Prima di arrivare direttamente al problema è importante, però, analizzare l'evoluzione storica di tutti gli interventi e delle idee che sono alla base delle decisioni istituzionali nei confronti di queste persone.

La storia del comportamento nei confronti di coloro che erano definiti «anormali» è una storia di atteggiamenti ambivalenti fra accettazione e rifiuto, in una prospettiva nella quale tuttavia tendono a prevalere esclusione ed emarginazione sociale.

Il rifiuto di stare insieme all'anormale, al diverso, all'estraneo è una reazione che ha sempre contraddistinto il comportamento umano in ogni epoca.

a) Il Medio Evo

Nel Medio Evo i grandi «rifiutati» erano i lebbrosi. Essi, infatti, erano costretti a vivere al di fuori della comunità sociale, segregati alle porte delle città in luoghi ben definiti e delimitati; quando alla fine del Medio Evo la diminuzione della malattia infettiva, dovuta non certo a pratiche mediche efficaci, ma al risultato naturale della segregazione e alla conseguente rottura dei focolai di infezione, lascia liberi molti spazi e strutture deputati all'ospitalità delle persone colpite dalla tremenda malattia, ecco che nei lebbrosari vengono rinchiusi altri rifiutati, altri diversi: gli «anormali».

Una nuova ossessione viene alla luce e ha come conseguenza l'assunzione dei medesimi meccanismi di rifiuto, e quindi di isolamento, sperimentati con la lebbra. Nel XVII secolo riscontriamo come la follia succeda alla lebbra quale «paura secolare e susciti al pari di essa reazioni tendenti alla segregazione, all'esclusione, alla purificazione»[1].

b) Il Seicento

Nel Seicento e in parte nel Settecento non ci si pone minimamente il problema di coloro che hanno bisogno d'aiuto a causa proprio del loro svantaggio fisico o mentale. Gli idioti, i pazzi vengono scacciati dalle città e sovente internati nelle carceri.

Tale fenomeno è comune in tutta Europa. Sorgono, infatti, a metà del XVII secolo, le grandi case di internamento, sia in Francia (*Hôpital général*), sia nei paesi tedeschi (*Zuchthäuser*), sia in Inghilterra (*Houses of correction*). Queste case a regime per lo più penitenziario, dove l'aspetto medico non era assolutamente importante, erano molto popolate: nel 1778, ad esempio, l'ospedale di La Salpêtrière ospitava circa 8.000 persone. In esse trovava sistemazione ogni persona che era considerata, non dal medico, si noti bene, ma dal giudice o dai gendarmi del

[1] M. Foucault, *Storia della follia nell'età classica*, Rizzoli, Milano, 1992, p. 15.